

2 - 01- Les cellulites cervico faciales d'origine dentaires - Pr. El Bouihi

Et on va traiter, est-ce que vous avez fait des cours de pathologie maxillofaciale? Qu'est-ce que vous avez fait comme cours? Buchan, Bouchedi, quoi d'autre? Rien d'autre, c'est bon. Alors, les cellulites cervicofaciales d'origine dentaire, c'est un cours que j'affectionne beaucoup dans la mesure où, si vous avez bien compris ce chapitre, vous serez peut-être amené un jour à sauver des vies avec des réflexes qui sont donc élémentaires et essentiels. On va commencer par la fin.

Le message qu'on veut passer à la fin de ce cours, c'est qu'une carie dentaire peut tuer. Écrivez-le quelque part et ça va vous servir dans votre vie, dans votre carrière médicale, professionnelle, mais aussi en tant que conseiller. Les gens qui sont autour de vous, votre famille, vos amis.

Une carie peut tuer. C'est une mort banale, la mort qui est causée par une appendicite, par exemple. C'est des morts, normalement, au 21^e siècle, qui ne devraient pas être répertoriées dans la population, mais malheureusement, on continue encore à voir de temps à autre des histoires fâcheuses.

Alors, normalement, les standards de l'OMS pour une visite médicale chez le chirurgien dentiste, c'est deux fois par an. Voyez déjà par vous-même et dans votre entourage, est-ce que vous avez cette habitude d'aller voir le dentiste d'une façon biannuelle? Si on pose la question d'une manière arbitraire maintenant, si on fait un vote, levez la main, qui c'est qui a vu le dentiste cette année? Comme ça, le chirurgien, avec un signe d'appel, mais comme ça, spontanément, il se dit voilà, je vais aller faire un tour chez le dentiste pour faire un détartrage et pour faire un dépistage des caries. Les caries ne peuvent pas être à tous les coups patantes, elles peuvent être cachées, surtout dans les faces d'accolement mesiodistales entre les dents.

Il y a des caries qui s'expriment sur la face occlusale des dents et des caries qui peuvent aussi se déclarer au niveau des faces d'accolement des dents latéralement. D'accord, c'est ces caries là qui sont insidieuses et qui avaient évalué à bas bruit et qui sont donc très pourvoyeuses de complications. Si on vous pose la question maintenant, je vais laver aussi ma main.

Je vais participer à ce vote. Qui c'est qui a pris l'initiative de lui-même pour aller faire, pour aller voir un dentiste cette année? Janvier 2023 là-bas, spontanément, comme ça, par amour à la, donc on est combien? Vous êtes une cinquantaine, une trentaine, une quarantaine? On a une, Anna Mamchitch, 2022, 2022, eh bien, la même personne. C'est votre père, c'est votre frère.

C'est ce que j'ai créé le dentiste. D'accord, donc tout ça pour vous dire que déjà, l'information pour aller voir et la conscience pour aller voir un chirurgien dentiste. N'est pas ancré dans les mœurs.

D'accord, on est un pays en voie de développement et le même constant. Il est vu même dans les pays qui sont développés pour d'autres raisons difficultés d'accès aux soins, les rendus pour

qui sont lointains. Il y a des problèmes aussi matériels, même si on est conscient.

On va rarement aller voir le dentiste pour dépister une carie. Donc, une carie dentaire compliquée peut tuer. Et c'est ça le message qu'il faut retenir.

Alors, c'est quoi une cellulite cervico faciale, donc cellulite cervico faciale, donc on sait très bien que ça va intéresser la région cervico faciale. On va voir comment. Donc, c'est juste cervico faciale se définit comme des inflammations profondes, des parties molles, des parties molles, c'est les tissus cellulaires graisseux, cervico faciale, donc d'origine dentaire.

Donc, bien sûr, on est dans le cadre de les cellulites d'origine dentaire parce qu'il y a encore d'autres cellulites qui peuvent avoir d'autres autres origines. Donc, c'est une infection qui est d'origine profonde, un pronostic potentiellement mortel. Donc là, on va utiliser le.

Alors. On va voir les choses d'une manière inversée, comme si on allait étudier des cellulites, des infections profondes au niveau du tronc des membres. D'accord.

Donc, de la superficie à la profondeur, qu'est ce qu'on a? On a. C'est la. D'accord. Sur la peau.

On a. Surtout. Nous, on peut avoir. Des aponevroses.

Tous ces cellulaires. Ici, c'est la peau rose. Après, on peut avoir des muscles, des muscles.

On peut avoir. Un périoste. Et puis, sous le périoste, on peut avoir.

De l'os. Vous avez un problème infectieux. Ça s'exprime par une papule, par une pustule, tout ce que vous voulez.

D'accord, on va commencer à creuser en profondeur. Et là, vous avez. La cellulite.

Et après, ça, c'est. Cellulite. Ici, on a une facillite.

Il est plus souvent l'écrose, parce que les facillites sont mal vascularisées. Donc, toute infection qui intéresse le facillite. S'exprime par une écrose, donc on a la facillite l'écrose.

Puis, on a une myosite. Puis, on a un abcès sous périoste. Puis, on a une ostéite.

D'accord, on peut avoir. Dans une évolution classique, une complication de l'infection profonde de l'héparthymole, la succession de ces différents stades. Le problème, c'est qu'au niveau.

De la base, on a les maxillaires qui sont porteurs de dents, d'accord? On va inverser. Le schéma et là, on a une dent qui est enchâssée dans l'os. Donc, le problème commence ici.

Et il monte de la profondeur. À la superficie, donc, si vous avez compris ce schéma, vous avez tout compris les cellulites d'origine dentaire. C'est des infections qui commencent par l'ostéite.

Et qui passe par l'abcès supériorité. Puis, la myosite qui va donner. Et je pense que mon collègue, professeur Abdeshadi, vous a parlé du trismus.

L'inflammation du mur. Donne une contracture musculaire qui est douloureuse, qui est à l'origine d'une limitation aiguë de l'ouverture du canneau. Puis, à la fin, on a la cellulite et les signes inflammatoires.

Tout à l'heure, on derrière les derniers sous forme de placard. Quand vous avez une cellulite d'origine dentaire avec des signes tout à l'heure, c'est déjà très compliqué. Quand on dit que c'est une infection, c'est une inflammation.

L'inflammation infectieuse est ici, c'est un agresseur. Cervical, facial, origine dentaire et c'est une infection qui est. D'ongle et profonde.

C'est en se rappelant de ce schéma là que vous avez tout compris. D'accord. Les signes qui tanné viennent en dernier.

D'accord, donc imaginez les choses à l'angle pour Vous avez bien ce schéma, je peux enlever, sinon vous avez le. Alors, on revient à cette diapositive, donc inflammation, c'est des inflammations des parties molles cervicofaciales d'origine dentaire. C'est des infections qui sont de manvelée profonde à pronostic potentiellement mortel.

Pourquoi c'est potentiellement mortel? Parce que si vous vous rappelez bien en cours d'anatomie de deuxième année. Le massif, que ce soit le massif facial ou la mandibule, c'est un socle squelettique qui est tapissé à l'extérieur par une cagoule cutanéomu musculaire, donc les muscles possiers et la peau est tapissé à l'intérieur d'une muqueuse, que ce soit une muqueuse de type digestive au niveau de la cavité orale ou respiratoire au niveau du nez. On avait dit que le massif facial abritait des organes du sens, donc les quatre organes du sens.

L'ouïe fait partie du paysage facial, mais au niveau du massif facial, on a l'odorat, la vision, l'agustation et la sensibilité. Mais aussi, la fin, en tant que région anatomique, c'est le départ des voies aërodigestives supérieures. Donc tout problème infectieux, tumoral, traumatique, il va entraver, que ce soit la fonction masticatoire, la fonction morphologique, mais aussi la fonction respiratoire.

Donc si vous avez de l'œdème, qui est important, il va rapidement être à l'origine d'une asphyxie, donc il peut être mortel. D'accord ? Donc on a une infection qui est profonde, au lieu de s'expandre à l'extérieur, elle va s'expandre à l'intérieur. Elle va vous comprimer les voies aërodigestives et aériennes supérieures.

Elle va vous donner une asphyxie. Donc ces patients qui ont des cellulites cervicofaciales d'origine dentaire sont guettés par la complication respiratoire. Écrivez-le, risque d'asphyxie et risque de décès par asphyxie.

Avant même le décès par sepsis ou la septicémie. On a une infection profonde. On avait dit que c'était potentiellement mortel.

On a expliqué une des raisons de décès, une des causes de décès, c'est l'asphyxie. D'accord ? Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a des muscles possiers. On a des muscles possiers qui sont circulaires et d'autres qui sont gradiaires.

Circulaires, c'est les orbiculaires des yeux et de la bouche. L'orbiculaire du nez est réduit à l'état vestigial parce qu'on a des mammifères qui respirent de l'air. Et on a des muscles possiers, gradiaires, qui ont au rôle l'ouverture des fentes, que ce soit la fente palpébrale ou la fente orale.

Donc pour permettre le glissement de ces muscles entre eux, il y a un coussinet graisseux. D'accord ? Un coussinet graisseux qui se glisse entre ces espaces, entre les muscles et qui est en intime relation avec la graisse sous-cutanée. On a vu sur le schéma la graisse sous-cutanée, mais il faut ajouter l'autre élément, c'est ce coussinet, ce corps adipe de la joue qui va s'immiscer un petit peu partout dans les interstices entre les muscles pour permettre la mobilité des muscles possiers, pour avoir une mimique qui est harmonieuse.

Ce tissu cellulaire, ce tissu graisseux, va servir de vecteur de propagation de l'infection parce que c'est une zone de faiblesse. Écrivez-le quelque part. Zone de faiblesse et pareil, zone de faiblesse infectieuse et par extrapolation aussi, zone de faiblesse tumorale.

On peut avoir des cellules tumorales, dès qu'elles sont greffées sur la graisse, c'est une voie de dissémination. D'accord ? Donc, entre le cou, entre la base de la mandibule, le sternum et la clavicule, on a ce fameux muscle platissmat. Déjà, en superficie, quand vous contractez, faites une mimique un petit peu forcée sur le cou, vous allez voir la contraction du muscle platissmat.

C'est le muscle possier du cou. Puis on a d'autres muscles, comme l'a dit le jeune homme, on a le muscle sterno-léidomastoidien qui va de la mastoïde à la clavicule et au sternum. Et on a aussi des muscles infraïoudiens qui vont de l'ostéoïde au sternum et à la clavicule.

Ces muscles-là ont des fascias et des aponévroses qui vont mettre en relation la partie basi-faciale vers la partie basi-cervicale. Écrivez-le, c'est des autoroutes de propagation de l'infection de la région faciale à la région cervicale et par extrapolation vers le médiastin. Les médiastinites sont pourvoyeurs de décès dans 8 à 9 cas sur 10 dans les meilleurs centres.

Deuxième cause de l'infection, c'est les médiastinites. Secondaire aux cellulites cervico-faciales d'origine dentaire. Vous avez une dent qui est carrée, l'infection qui se déclare en basi-faciale puis en cervicale et de là, c'est la médiastinite.

Médiastinite, ça veut dire du pus autour des gros vaisseaux du thorax. Dans le médiastin, c'est pourvoyeur de décès par phénomène de sepsis grave. Troisième cause de décès, je ne sais pas si j'ai mis une diapo, mais rappelez-vous de cette artère.

On avait parlé de l'artère faciale dans la vascularisation de la face en deuxième année ? Vous avez une artère faciale. L'artère faciale, ça vous dit quelque chose ? C'est l'une des artères principales de la vascularisation de la face. Elle apparaît au niveau de la face, à ce niveau-là, au niveau de l'échancrure pré-angulaire.

Elle a un trajet oblique en direction, en haut et en avant, en direction de l'angle interne de l'œil ou contus interne de l'œil. Sauf qu'au niveau des bouquins d'anatomie, on dessine souvent cette artère faciale de bout en bout. C'est une autre erreur sur le schéma.

L'artère faciale commence ici et elle a un trajet comme ça. Elle se projette précisément au niveau du sillon nasogénien en superficie. Dans 15% des cas seulement, elle arrive à l'angle interne de l'œil.

Et dans la majorité des cas, soit elle se termine par une artère coroner labiale inférieure ou coroner labiale supérieure ou infranasale ou artère transverse du nez. Rappelez-vous par exemple, 15% ici, 15% là, là. Donc une fois sur six, elle arrive ici, saine et sauve jusqu'à l'angle interne de l'œil.

Et elle s'anastomose dans une fois sur six en plein canal avec l'artère angulaire de l'œil qui est, elle, d'origine carotidienne interne. Donc on a un champ entre la carotide interne et la carotide externe. Donc je vais vous encombrer un petit peu avec des notions anatomiques.

Elle est angulaire une fois sur six. Pareil, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Le un sur six, c'est ce qui pose le danger d'une complication.

On vous a certainement vu, vous en parlez dans le cours de dermatologie. C'est la thrombophlébite du sinus caverneux. Ça vous dit quelque chose ? On vous a expliqué comment ? Ce n'est la physiopathe.

Ce n'est pas grave. Donc le sinus caverneux, c'est une veine. D'accord ? C'est un sinus veineux vers lequel se drainent toutes les veines mélangées et cérébrales.

D'accord ? Il est de part et d'autre de la selle turcique. Écrivez sinus caverneux. Vous allez voir ce soir sur Internet les schémas.

Vous avez le sinus caverneux qui est de part et d'autre de la selle turcique. D'accord ? Au niveau du corps humain, toutes les artères et toutes les veines sont satellites. On peut avoir une artère et une veine satellite, comme ce que vous voyez ici.

L'artère radiant, son trajet, et la veine, elle l'accompagne. D'accord ? Là, on peut avoir une artère et deux veines satellites, comme au niveau des membres, par exemple. D'accord ? Au niveau intracranien, le sinus caverneux, c'est la seule veine de l'organisme où l'artère est dans la lumière de la veine.

Vous avez le sinus caverneux et dans la lumière du sinus caverneux, vous avez l'artère carotide interne. D'accord ? C'est une exception. Imaginez que vous avez un problème infectieux ici.

Il y a une fragilisation de la paroi artérienne. Passage d'un thrombus bactérien dans la lumière de l'artère. Le flux au niveau de l'artère faciale dans la région périangulaire interne de l'œil, on ne sait pas s'il est centrifuge ou centripète, s'il va de l'intérieur à l'extérieur ou à l'inverse.

L'essentiel, c'est que ce thrombus bactérien peut migrer dans la lumière artérielle. D'accord ? Et aller là où le débit s'amointrit, et plus précisément au niveau du siphon, parce qu'il y a un siphon carotidien dans le sinus caverneux, il va se plaquer contre la paroi, il va l'éroder, et il va faire ce qu'on appelle une fistule, écrivez-le, fistule carotido-caverneuse. Ce n'est pas une fistule traumatique, c'est une fistule infectieuse, parce que la paroi artérielle a été érodée, et il y a eu un change entre l'artère carotide interne et le sinus caverneux.

Résultat de la course, on a une équilibration des veines entre système artériel et système veineux. Le sinus caverneux, lui, il draine parmi, entre autres des territoires qu'il va drainer, il va drainer les veines orbitaires. Il va vous donner une exophthalmie.

Ça va donner une turgescence au niveau de la rétine. Les cellules nerveuses sont très sensibles aux hémorragies, donc ça va se solder par une perte définitive de l'œil. Évidemment, on a des bactéries dans le sang, c'est une septicémie.

On a une septicémie, une fistule carotido-caverneuse, un risque de cécité. Même s'il ne meurt pas, il va perdre l'œil. Il a une méningite, tout ce que vous voulez, il a un abcès intracérébral.

C'est la troisième cause du décès par cellulite d'origine dentaire. Vous voyez une carie, qu'est-ce qu'elle peut vous donner ? Si vous avez des caries périmaxillaires supérieures, vous êtes guetté par la thrombophlébite du sinus caverneux. C'est pour ça qu'on vous a dit en dermatologie, qu'il ne faut pas manipuler les furoncles de la face et surtout dans la région latéronasale, parce que ça affaiblit la paroi artérielle et ça peut donner une migration d'un thrombus bactérien.

Les cellulites qui sont basses exposent au risque de phacéites nécrosantes et de médiastinites. Les cellulites qui sont internes, parce que les cellulites ne peuvent pas seulement s'exprimer à l'extérieur, mais peuvent s'exprimer aussi au niveau de la face interne, de la mandibule ou du maxillaire, pour vous donner une asphyxie au niveau de l'isme de Gauzier, au niveau de la base de la langue, et vous donner une asphyxie. C'est la première cause de décès par cellulite.

Il a fait mon propos concernant les objectifs bien. C'est bien clair les schémas, d'accord ? Alors, si on veut comprendre, tous là, on est tous ici, comme j'ai l'habitude de dire, en liberté provisoire. D'accord ? On n'est pas juste guettés par la mort, dû au tremblement, au séisme, les hasards, tout ce que tu veux.

On a des tremblements de terre dans nos bouches. Abusez-vous bien de ne pas vous brosser

les dents 24-48 heures, et vous allez voir l'haleine de poney que vous aurez. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a une flore bactérienne qui est active, et qui est là juste pour nous pourrir la vie.

Donc, c'est une flore qui vit avec nous, qui forme une barrière biologique, mais elle est prête à devenir pathogène. Elle s'approprie, mais elle peut être pathogène à l'occasion d'une baisse de l'immunité générale ou locale. D'accord ? C'est quoi le parodent ? Le prochain cours de tumeur bénigne et maligne des maxillaires, on verra tout ça avec d'autres schémas, et on va se rappeler de ça.

Mais le parodent, là vous allez l'imaginer, c'est le tissu de soutien de la dent. D'accord ? On a l'os maxillaire, que ce soit la mandibule ou le maxillaire, qui est creusé d'alvéoles, et les racines des dents sont enchâssées dans les alvéoles. Et ce qui permet de maintenir la dent dans son alvéole, c'est le parodent.

Donc le parodent, il est formé de quoi ? Il est formé de ligaments desmodontales, c'est-à-dire légalement alvéolodentaires. Puis, l'os alvéolaire lui-même, parce que c'est un os, on dit que l'os alvéolaire, c'est un os qui naît, qui vit et qui meurt avec la dent. Les bébés, avant l'éruption dentaire, n'ont pas d'os alvéolaire.

Ils ont juste un os basal et une plaque dentaire qui est active. Quand il y aura une éruption, c'est avec l'éruption dentaire qu'il y aura une distraction de l'os pour former l'os alvéolaire. Et pareil, quand on enlève une dent, l'os alvéolaire va involuer et vous n'avez qu'à voir les maxillaires, les mandibules de nos grands-parents, vous allez voir qu'ils ont des mandibules qui sont peu épaisses et peu hautes, qui perdent en hauteur.

Troisième élément, c'est la gencive attachée. Comme il y a un stretching de l'os, il y a aussi un stretching de la muqueuse. Vous avez une fibre muqueuse qui est attachée, c'est la gencive.

La gencive, elle, autour de chaque collé de dent va servir de joint hermétique. C'est pour ça que quand on va chez le parodontiste, il nous fait un test avec des sondes paro. Il met une sonde, des instruments qui sont coudés, pointus, et il les fait rentrer profondément entre la dent et la gencive à partir du collé pour voir l'étanchéité du collé gingival.

Cette disposition, de cette manière, va former une barrière anatomique mais surtout biologique. C'est ce qui va permettre d'isoler le monde extérieur. Au niveau de la bouche, qui est truffée de bactéries, qui est hostile sur le plan chimique.

On a une salive qui est basique. Elle est truffée aussi d'enzymes parce que s'il n'y a pas cette qualité hermétique du collé dentaire, notre propre salive irait ronger nos propres composants anatomiques. Donc, hostilité chimique, hostilité bactériologique, hostilité enzymatique.

C'est pour ça que les gens qui ont des parodontistes, le problème qu'ils ont au niveau de la bouche ne reste pas plié au niveau de la bouche. C'est une maladie à impact général. C'est des

gens qui sont souvent fatigués, qui ont des états inflammatoires qui sont éparpillés dans le corps.

Ils ont des arthralgies, des myalgies, des tendinites, des migraines, tout ça parce qu'ils ont un état inflammatoire qui intéresse tout le corps parce qu'ils ont une barrière anatomique qui est fragilisée, comme l'intestin inflammatoire. Vous entendez parler des intestins inflammatoires avec tous les produits alimentaires qu'on mange et les conservateurs et ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas un parodonte qui est intact, dites-vous bien que vous avez mis le premier pas, le premier pied sur la première marche pour développer une cellulite d'origine dentaire.

Donc, la dent, elle, elle est faite pour résister. Il y a l'émail, la dentine, le sément. À l'intérieur duquel, là, c'est la couronne.

Vous avez l'émail. Ici, on a la dentine. Puis, en périphérie, on a le sément.

Et on a la chambre pulpaire. On va voir après, dans notre cours, l'origine ombriologique de tout ça. Que ce soit l'émail ou la dentine ou le sément, c'est des cellules neuroectodermiques.

Mais la... On n'a que des dents cariées. Mais la chambre pulpaire est d'origine mésodermique. Elle est porteuse d'artères, de veines et de nerfs.

Il y a un paquet vasculonerveux qui se loge ici, dans la chambre pulpaire. L'intégrité de cette... de cette anatomie fait que cette chambre pulpaire est isolée du monde extérieur. Elle n'est pas en contact ni avec bactéries, ni avec aliments, ni avec salive, ni quoi que ce soit.

Donc, s'il y a une ouverture de cette chambre pulpaire, il y a une réaction inflammatoire qui va se faire au niveau de l'apex dentaire. C'est ce qu'on appelle le granulome apicotentaire. Écrivez-le, granulome équivalent, l'équivalence monsieur portable rouge, vous pouvez sortir.

Je vais te dire Bravo. Ah vous prenez les notes. Eh bien.

Je suis content. Alors, mais si vous prenez des notes comme ça, je prends des notes sur mon portable, diagnostic différencié, d'accord? Granulome apico dentaire équivaut à un ganglion lymphatique. Vous avez par exemple une blessure.

Vous avez un bouton, d'accord? Vous avez un problème infectieux quelque part, vous avez un ongle incarné, tout ce que vous voulez. Il va se s'exprimer par une adénopathie, soit au niveau hépitrocléa, on a au niveau du creux axillaire. Pareil pour le pour le membre inférieur.

C'est au niveau du pli de laine. Avant qu'il y ait un ganglion ici sous maxillaire, par exemple, vous avez le granulome apico dentaire que lui va servir de premier relais infectieux pour contrecarrer l'agression infectieuse. Donc si vous avez une intégrité de l'anatomie dentaire qui est compromise, vous avez mis un deuxième un deuxième pied dans la deuxième marche pour développer une cellulite d'origine dentaire.

Donc intégrité du parodent intégrité de l'anatomie dentaire qui peut être compromise soit par un traumatisme, soit par une carie. D'accord? La carie, elle est causée par quoi? Je suis la physiopathe de la carie. C'est de l'acide lactique.

Vous avez des aliments surtout sucrés. Ils sont consommés par les aliments. Donc la carie dentaire, c'est une carie dentaire, c'est une carie dentaire, c'est une carie dentaire, l'inflammation c'est l'infection la plus répandue dans le monde.

L'humanité Y'a pas un être humain dans votre bouche serez que vous êtes des grands menteurs. La première dent qui se carie dans la bouche laquelle d'accord? Laquelle? Il y en a une à faire. la première molaire droite ou d'accord? parce que c'est la dent la plus vieille dans votre bouche.

Non, même pas. C'est la dent la plus vieille. C'est la dent de six ans.

Depuis six ans. Et d'ailleurs l'enfant il a juste les les dents lactéales au niveau des pré-molaires. Les molaires lactéales seront remplacés par les pré-molaires de l'adulte.

D'accord? L'enfant, un enfant de cinq ans ou de quatre ans, il n'a pas une six. Un dos incisif, un dos nièbre, les trois, et il a les quatre et les cinq. Un autre numérotation.

Un, deux, un, deux, trois, quatre, donc quatre secteurs, un, deux, trois, quatre. Chez l'enfant, cinq, six, sept, huit. Donc ces dents se terminent.

C'est la cinquante-cinq, c'est la soixante-cinq, c'est la soixante-quinze, c'est la quatre-vingt-cinq. D'accord? Il y a pas de quatre-vingt-six, il y a pas de soixante-six. Mais on a une seize, on a une vingt-six, on a une trente-six et une quarante-six.

D'accord? Donc ça que ça soit la seize ou la vingt-six, c'est la première dent qui fait apparition donc donc elle est vieille. Donc elle suse. Deuxième chose, c'est que le canal parotidien va venir s'ouvrir par un ostium qui va déverser la salive exactement au niveau du collet de la cis.

Donc mettez votre langue au contact de la joue en face du collet de la cis et vous allez sentir une petite excroissance. C'est l'ostium du canal parotidien. Donc vous avez de la salive qui est déversée sur cette dent, la peau du matin au soir.

Donc et c'est pour ça qu'elle finit par craquer. Donc il n'y a pas une bouche dans le monde qui n'a pas été, qui n'a pas connu de caries dentaires. Donc immunité locale générale, vous l'imaginez bien.

D'accord? Donc l'immunité locale peut être déjà compromise par une anatomie qui n'est pas normale. Donc imaginons des encombrements dentaires. Donc pour revenir à la remarque de notre ami, donc brossage difficile, des dents qui se chevauchent, donc des zones qui sont inaccessibles au brossage dentaire.

Donc plus de pullulation de germes et moins de capacité à résister. Et cette anatomie peut être compromise à l'occasion d'un traumatisme, chose comme ça. Donc là, l'immunité générale, donc diabète, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, état général donc qui est dégradé.

Donc c'est toute l'immunité qui est compromise. Et on va ajouter une autre chose. C'est une prise de certains médicaments qui sont très répandus.

C'est là où va résider votre rôle. C'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si vous avez des dentistes dans votre entourage, faites-leur le topo.

On reçoit beaucoup de patients qui sont passés par la consultation de leurs confrères dentistes et chez qui ils ont eu droit à des prescriptions d'anti-inflammatoires non stéroïdiens sans antibiotiques. Donc c'est une pierre deux coups. C'est l'inflammation, c'est l'analgésie et il détériore l'immunité locale pour favoriser une série d'origines dentaires.

Moi, je ne prescris jamais d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Que ce soit dans un contexte infectieux ou tumoral ou traumatique ou tout ce que vous voulez, jamais d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si vous voulez prescrire des anti-inflammatoires, prescrivez des corticoïdes stéroïdiens, d'accord ? Et puis il y a le conseil thérapeutique chez les pharmaciens.

Donc le patient, il arrive, il vous dit voilà, j'ai mal à la dent. Au lieu, pour des raisons économiques, il n'a que 50 dirhams, 20 dirhams dans la poche, prenez celui-là, il va vous rendre service. Donc si vous avez des pharmaciens dans l'entourage, faites-leur l'éducation de ne pas donner des anti-inflammatoires aux gens.

Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur bouche, s'ils ont ou pas des conditions locales ou générales favorables à la déclaration d'une séisme. Parce que si lui, il vient avec une rage dentaire, c'est qu'il a un problème qui est en train d'évoluer. Avec l'anti-inflammatoire, c'est le coup d'envoi pour les problèmes.

D'accord? On sait où les dentistes, où les les pharmaciens qui sont autour de vous. Alors vous allez me dire pourquoi on prescrit des anti-inflammatoires aux papiers, aux amis qui ont des douleurs, l'ombert, douleurs rhumatismales, parce qu'ils ont des, des, des bouches qui sont édentées. Parce que lui, il a des, des maxillaires qui sont déshabités d'eux.

C'est un coup de bonne. C'est un coup de chance. La grand-mère elle utilise elle, elle fait des elle est suppositoire pour son problème de dos, des années, des années, n'a jamais développé.

Non, parce qu'elle n'a pas de dents, elle a un dentier. D'accord? Chez le jeune, non, ne prescrivez pas d'anti-inflammatoire tant que vous n'êtes pas sûr de l'état buccodentaire du patient. Donc la flore bactérienne, bien sûr, on ne cessera jamais de parler de l'hygiène buccodentaire, d'accord? Et le brossage des dents.

Alors les germes, la mètre, c'est une flore qui est polymicrobienne, oxygramme positif, BGN, anaérobi, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que quand on prescrit des antibiotiques, c'est des antibiotiques à large spectre et on cible les anaérobies, donc les voies de pénétration et de transmission, donc voie périostée, lymphatique directe, tout ce que vous voulez, ce n'est pas un problème. Donc l'éthiopathogénie, la première cause, c'est la carie.

Secondairement, c'est la parodontopathie et les traumatismes. Après, va venir se greffer le kyste, donc déjà le granulome radiculodentaire ou apiculodentaire, quand il va devenir un peu plus grand, on l'appelle kyste radiculodentaire parce qu'il y a une activité ostéoclastique et c'est ça le malheur. C'est que le problème, il est au niveau des maxillaires et par une activité ostéoclastique de ce kyste, il y aura une érosion dentaire pour que ce kyste déverse son contenu sceptique en supériostée.

Et après, au niveau du tissu cellulaire, sous-cutanée et la boule de bichat où le corps a du peu de l'ajout. Donc baisse de l'immunité générale ou la locale due aux ANS, dissémination de proche en proche et puis vous avez les voies express de dissémination, c'est les zones de faible résistance. On a parlé du corps a du peu de l'ajout mais on a parlé aussi des fascias, des muscles cervicaux, que ça soit possié ou la sternocleidomastoidienne ou la infrahuidienne.

D'accord ? Bon ça c'est des valeurs prédictives, c'est qu'au niveau du maxillaire, c'est au niveau de la lèvre et au niveau du vestibule supérieur. Les prémolaires c'est au niveau du palais et ainsi de suite. La mandibule antérieure c'est plutôt vers la lèvre et vers l'ajout.

Moyen et postérieur c'est plutôt vers l'oropharynx. Donc vous aurez tout ça. Donc l'origine dentaire, donc l'organe dentaire, on a une atteinte carieuse, traumatique, sulculaire c'est le parodente, gingivite, parodontite et ainsi de suite et qui converge tous vers le granulome apico-dentaire et de là des complications infectieuses locales et régionales, c'est la cellulite cervicofaciale générale, c'est le sepsis généralisé.

La flore bactérienne, elle est polymicrobienne. D'accord ? On va passer, ça c'est pour bien comprendre le cours, on va en venir au type de description, ça c'est normalement vous en tant que médecin, vous devez intercepter le patient dans cette phase-là. Parce que les cellulites d'origine dentaire peuvent être classées en cellulites bénines ou malines, comme les tumeurs.

Une cellulite bénine, si elle est bien traitée, elle rentre dans l'ordre, on n'en parle plus. Bien sûr, on va en parler sous d'autres formes, sous forme de prévention pour qu'il n'y ait pas d'épisode similaire. Mais il y a des cellulites qui sont malines, le patient va devoir séjourner en réanimation, va devoir suivre des interventions qui sont délabrantes et des conséquences fonctionnelles souvent handicapantes.

Donc normalement, le type de description sur lequel on va insister, c'est la cellulite périmaxillaire. Quand on dit maxillaire, ce n'est pas seulement le maxillaire. La mandibule, elle aussi, elle est

considérée sur le plan anatomique un maxillaire.

Donc cellulite périmaxillaire, quand on dit périmaxillaire, elle est soit extérieure, soit intérieure par rapport à l'os. Non collectée, ça veut dire qu'elle est inflammatoire, elle est encore inflammatoire, elle est circonscrite, elle intéresse une zone. D'accord? Je t'envoie des signes fonctionnels.

Le patient, il va venir vers vous avec quel tableau? Il va venir dans un tableau de thuméfaction, douloureuse, lancinante, dans un contexte subfébrile. La douleur lancinante, c'est quoi? Quand on dit douleur lancinante, ça va faire des différences entre différents types de douleurs, douleurs inflammatoires, douleurs cancéreuses, douleurs traumatiques, douleurs onguineuses. Et le patient, il vous décrit la douleur, vous pouvez la relier à une étiologie.

C'est ça la clinique. On vous dit que c'est une douleur qui est lancinante. C'est un terme qui est purement français.

C'est aussi un système de Avec des piques, les piques ils sont rythmés par quoi? Ils sont rythmés par le rythme cardiaque. C'est des battements la région. C'est pour ça que la cellulite elle se déclare le soir ce qui est un rythme de perfusion le corps aux répartitions de perfusion qui surtout quand on se met en d'accord? Il y a plus de perfusion de l'extrémité de l'hémicéphalique.

La dent, c'est pour rigoler, ne prenez pas comme c'est comme une catégorie de professionnel la vieille profession de l'humanité, travailler la nuit et le week-end. D'accord? C'est une douleur d'accord? D'accord? C'est une douleur qui est lancinante, rythmée par le rythme cardiaque. Le trismus plus ou moins selon la localisation.

Si c'est une cellulite qui est antérieure, donc qu'il n'y a pas péri buccale, péri labiale, il n'y a pas d'insertion musculaire. Par exemple, le muscle masséteur, il s'insère au niveau du corps de l'os zygomatique à l'angle mandibulaire, à la face externe de l'angle mandibulaire. C'est ces muscles-là qu'on palpe quand on serre les dents.

Donc, si il y a une cellulite qui est en contact du masséteur, c'est le trismus. Si on a une inflammation qui est en contact avec le pterygoïdien médial, c'est son image en miroir par rapport à l'oramus, on a un trismus. D'accord? Si on a une cellulite qui est en rapport, une inflammation qui est en rapport avec le muscle temporal, on a le trismus.

Donc le trismus, lui, il est dicté par la localisation de la cellulite. A l'infirmité, des lèches, c'est les anaérobies. Si vous avez déjà senti l'odeur d'une infection, la germe anaérobie, c'est pour la mémoire à vie.

Donc quand je rentre pour faire la visite près de mes malades, quand il y a une infection anaérobie qui se déclare, je la sens sans même faire un écouvillonnage, l'entraînement bactériel. Et le patient vous rapporte un antécédent récent de la dent. D'accord? La névralgie dentaire peut

être présente, comme elle peut être dans les antécédents.

Je vous explique. Il vous fait un problème dentaire. Il a une carie.

Cette carie se sonde par une pulpite. La pulpite, c'est normalement la pulpite normalement dans une chambre pulpaire qui est hérémétique. C'est une douleur.

Une douleur cancéreuse. Pourquoi? Parce que vous avez une inflammation qui intéresse une chambre qui est inextensible. Vous avez l'œdème dans une chambre pulpaire qui est inextensible.

Donc une douleur avec pression. Le soulagement, c'est la cavitation. Donc on cavite la carie et on draine la pulpe à l'extérieur.

Dès qu'on met une aiguille, c'est le soulagement. Donc une douleur 10 sur 10, 1 sur 10, donc le patient ne sent plus rien. Ou là, elle peut, la la névralgie dentaire elle est juste, un signe, puis après la dent se mortifie.

Si elle se mortifie, si elle meurt, la dent, elle sent plus rien. Donc il peut vous décrire une névralgie d'origine dentaire. Les antécédents, il y a une semaine, il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois.

D'accord? Et après je n'ai plus entendu parler de ça. Mais le problème infectuel était encore là. Et il a aussi un cadavre à l'intérieur.

Il a une dent qui est morte, qui se défend pas, qui est en train de se putrifier et ainsi de suite. D'accord? Imaginons, il a un cadavre dans son maxillaire qui est en train de putrifier. Et un jour, il se déclare par une célite.

Donc là-dedans, il y a toujours un antécédent de la dent qui peut être plus ou moins récent. Une semaine, deux semaines. Ou là, il peut être subaigu pour lequel il a mérité un, une visite chez le dentiste qui a essayé de de cureté ou la extraire.

Il n'a pas pu se se faire. Il a essayé de l'extraire, il l'a cassé, il a la il a laissé un bout de racine. Ou là, il a eu droit à une médication qui est qui est moyenne, anti-inflammatoire par le dentiste, par le pharmacien et il est venu avec ce tableau de célite.

Donc toujours poser la question sur une histoire dentaire qui cachait quelque part, même dans un, dans un souvenir lointain sur deux, trois, quatre mois, six mois. D'accord? Donc c'est une tumefaction douloureuse lancinante subfébrile. Donc vous, en tant que patient, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le palper.

C'est une palpation qui est douce. D'accord? Déjà, vous avez la tumefaction. Ça va faire la différence entre tumefaction et nodule.

Nodule Nodule D'accord? Donc c'est un un gonflement harmonieux, d'accord? Avec des angles de raccordement qui sont ils sont pas aigus, ils sont doux, ils sont ouverts. Donc c'est en pente douce, d'accord? Le nodule, ça fait adénopathie. Donc ça veut dire qu'il se raccorde avec le tissu, ça, avec un angle, il n'est pas doux, qui est aigu.

D'accord? Donc vous avez la tumefaction, mais le plus important, donc c'est une tumefaction qui est élastique, elle ne prend pas le godet. Donc vous appuyez dessus, vous savez ce que ça veut dire le godet, d'accord? Vous appuyez dessus, d'ailleurs s'il vous laisse le palpé de cette manière, parce que c'est une douleur qui est vive. Donc vous posez votre doigt, vous levez le doigt, la tumefaction reprend son volume et sa forme, d'accord? Et rapidement.

Donc il n'y a pas de godet. Mais il faut faire une relation, donc pour établir une relation entre la tumefaction et la dent. Le signe de la tumefaction, c'est qu'il n'y a pas de pneumonique.

Et ça, j'insiste dessus, mes visites avec les résidents, c'est que le vestibule, lui, il est comblé. Tu sais le vestibule? C'est quoi le vestibule? Le vestibule, ouais, le vestibule c'est ça. C'est cette zone de réflexion entre muqueuse attachée au maxillaire et muqueuse, qu'elle soit jugale ou la labiale.

Le fond. Normalement, c'est une concavité. C'est une concavité.

Normalement, c'est un espace qui est virtuel. C'est un espace virtuel qui est rendu réel par l'écartement de la jaune à la lèvre. C'est quand on met notre abaisse-langue que cet espace normalement est juste à coller, d'accord? Qui est virtuel, va devenir réel en écartant avec une abaisse-langue.

Ou là, un miroir. C'est quoi le vestibule? Dans l'arabia D'accord? D'accord? Alors donc pour dire que entre le problème qui se passe ici et l'origine dentaire donc apicale ou parodontale, il faut que ce vestibule soit comblé. Il perd de sa concavité.

Il devient plein. Et tu sens qu'il y a du matériel. Il y a de la pâte.

Il est empâté. D'accord? On examine là-dedans. On dit que c'était une cellulite inflammatoire circonscrite.

D'accord? Donc forcément, il n'y a pas de pus. Et il n'est pas rare de retrouver une adénopathie sous-ongulomondibulaire. D'accord? Donc c'est le territoire de drainage de la cavité buccale.

Premier relais gonglionnaire, c'est au niveau des gonglions submondibulaires. Et on recherche le trismus et on le quantifie. D'accord? Une ouverture buccale normale.

Trois centimètres. Quatre. Très bien.

Une ouverture buccale C'est ses doigts à elle. Les doigts du patient. Donc c'est trois travers de

doigts.

D'accord? Trismus, c'est à partir de deux travers de doigts. Vertical, comme ça. Trismus serré, c'est un travers de doigts.

Très serré, c'est même pas la pulpe de doigts. Ouverture buccale normale, trois travers de doigts. Au plus, des gens qui ont une laxité ligamentaire, on fait une morphaloïde.

Deux travers de doigts, Trismus Très serré, un travers. Très serré, même pas une pulpe de doigts. Donc devant ce tableau, on demande un orthopantomogramme qui est communément appelé radiopantomique dentaire.

C'est pas une radiopantomique dentaire, c'est une tomographie. C'est l'orthopantomogramme. Il va objectiver, donc il va identifier la dent qui est en cause, qu'on a suspecté à la clinique, d'accord ? On va objectiver une radioclarité au niveau de l'apex.

J'avais dit que c'était le primomovins, on a la carie, puis on a le granulome apicodentaire. Mais elle permet d'écarter. On demande assez souvent un orthopantomogramme pour écarter les autres résiduologiques qu'on va voir tout à l'heure.

C'est le diagnostic différentiel. On demande systématiquement une CRP. Comme je dis à mes résidents, c'est la prise de température biologique.

Généralement, les patients sont médiqués, ils peuvent avoir pris des analgésiques, d'accord ? Des anti-inflammatoires. Et ça peut fausser la température, d'accord ? Mais la CRP, elle ne ment pas. La première CRP permet d'avoir une base de comparaison pour monitorer toute l'évolution clinico-biologique sous traitement.

Numération formule sanguine, bien sûr, on voit les blancs. Et on demande une glycémie, une fonction rénale, une fonction hépatique. Rappelez-vous de ces états de baisse de l'immunité générale dû à des parts associées, que ce soit un diabète, une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique.

Diabète a été inaugurée par une sévite d'origine dentaire. Et moi, j'ai eu droit à des patients au service, des femmes enceintes, au troisième trimestre de la gestation, qui font des cellulites. Je vous conseille, vous, les filles, qui ferez certainement un jour des bébés, soignez vos dents avant de tomber enceinte.

Donc déjà pour la photo, merci. Ça sera. Mais parce qu'au niveau du troisième trimestre, on peut avoir des diabètes gestationnels.

Il y a des troubles de l'immunité. Déjà, les patientes, normalement, une femme enceinte, elle a un état de baisse de l'immunité naturellement. Pourquoi la femme enceinte, elle a une baisse de l'immunité d'une manière naturelle ? Pour ne pas rejeter le fœtus qui a un HLA qui est autre que

le sien.

Pour lutter contre le phénomène de rejet. Parce qu'elle a un corps étranger dans son corps pour ne pas le rejeter. Et là, elle a une immunité qui est basse.

C'est pour ça que les femmes enceintes n'ont pas développé beaucoup de complications, sauf le COVID. Parce que le COVID, c'est un emballement désimmunitaire. Les femmes enceintes, on n'a pas vu trop de complications pour les femmes enceintes.

Donc, les femmes enceintes, au 3e trimestre de la gestation, développent souvent des sévoulites transidentales. Et imaginez le circuit dans la réanimation, des arrêts de grossesse, des avortements et ainsi de suite. Alors, de cet état qu'on vient d'étudier, on peut évoluer dans un sens comme dans un autre.

Donc là, elle est inflammatoire, elle peut se collecter. Donc, elle peut se collecter d'elle-même comme elle peut se collecter sous antibiotiques. C'est pour ça que, quand on hospitalise nos services, les sévoulites d'origine dentaire, on les met sous antibiotiques 24-48 heures pour voir est-ce qu'elle va, est-ce qu'il y a une régression spontanée des signes cliniques et une évolution favorable de la biologie où là, il peut se collecter sous antibiotiques.

À ce moment-là, il faut continuer encore la médication par un geste de drainage chirurgical. Donc, on était dans le cas d'une sévoulite qui est circonscrite et elle peut évoluer vers l'extension. On dit que c'est une sévoulite qui est diffusée.

Donc, elle peut être diffusée de manière inflammatoire et elle peut être diffusée sous forme collectée. Donc, involution, collection, diffusion. Il y a aussi les cas où on a des sévoulites qui d'emblée diffusent.

Soit diffusées, soit d'emblée diffusées. Si vous revenez à ce slide, vous allez comprendre comment les choses évoluent. On a préféré vous figer l'image autour de ce tableau clinique central et faire évoluer les choses de différentes directions.

Là, chez les immunocompétents, on voit ça chez les jeunes. Vous avez des jeunes qui ont un état buccodentaire. Il est jeune, il a 18 ans, immunocompétent, il n'a pas de tarte, mais il a un état buccodentaire lamentable.

C'est des enfants qui avaient droit à des bonbons, des sucettes. Il a un état désastreux et il vient vous voir avec un abcès supériorité. Ça chauffe, il prend des antibiotiques, ça a un volume et il a toujours une masse qui prend corps avec la mandibule ou avec le maxillaire.

Là, c'est la fistule. La fistule, c'est une forme de guérison naturelle. Les fistules, quand un patient vous fistulise quelque chose, c'est que son corps a orienté le problème infectieux vers l'extérieur.

Il déverse le pus, il est là, le pus ne va pas le tuer, il va juste le déranger. Les fistules au niveau

de la face, au début elles sont papuleuses et après elles deviennent embiliquées. Elle a un nombril ici.

Mais normalement, c'est une forme de guérison. Nous, on va faire la cure de la fistule, on enlève la fistule, le trajet fistuleux, on va jusqu'au contact de l'os, on cure le granuloma picodentaire et on enlève la dent qui est en pose. De cette évolution, on peut... Si on vous pose la question, on a des cellulites subaiguës ou chroniques, on a des cellulites circonscrites collectées ou pas, on a des cellulites qui sont diffusées ou diffusées.

Les cellulites diffusent d'emblée, c'est parce qu'on a des germes qui sont très pathogènes. Là, on a un terrain qui est fragile ou fragilisé. Les cellulites d'emblée diffusent, on les voit chez les gens qui ont pris des ANS.

Au lieu d'avoir un petit problème infectieux qui va partir sur les antibiotiques au bout de 4-5 jours, on lui donne des ANS et il passe un mois au service. Puis on a des cellulites qui sont gangréneuses. Quand on a une forte composition en anaérobie, on a des cellulites gangréneuses.

Cliniquement, elles s'expriment par des crépitations neigeuses sous la peau. Vous avez un amphisème sous-cutané. Vous passez votre doigt sur la peau et vous avez l'impression d'éclater des bulles de savon sous la peau.

Puis on a les formes topographiques et on a des formes compliquées. On a vu les complications, c'est l'asphyxie, c'est la thrombofilbite du sinus caverneux et on a la médiastinite. Les formes topographiques, vous en avez de toutes les couleurs.

Par exemple ici, on a une molaire avec une carie, un granulome apicodentaire sur la racine palatine. Ça creuse et ça vous donne un abcès supériorité palatin. Normalement, la gencive attachée c'est une muqueuse qui est attachée directement à l'os sans coriandre.

La gencive est plaquée contre l'os sans coriandre. Elle a une vascularisation propre mais une vascularisation de proche en proche par l'os. Vous avez la bielle supérieure, vous avez la sonarinaire, vous avez la jugale et ici on a le muscle buccinateur.

Là, vous avez l'attache du muscle buccinateur. Ça, c'est un abcès vestibulaire supérieur. Si elle s'exprime au-dessus de l'insertion du muscle buccinateur, vous savez ce que c'est ? C'est le muscle du trompettiste.

C'est le muscle qui sert à vider la pression. Pour vider l'air, c'est la contraction du muscle buccinateur. C'est le muscle du trompettiste.

Si vous avez de l'activité ostéoclastique qui va au-dessus de l'insertion du muscle buccinateur, vous avez une génienne haute. Vous avez tous les cas possibles et imaginables. Ici, on a la sublingualite, on a la sous-myloïdienne et on a une qui est très dangereuse.

C'est la sus-myloïdienne. On va la voir. C'est ce qu'on appelle l'angine de Ludwig.

Imaginez que vous avez un problème au niveau d'une cis inférieure. On a une cinq inférieure qui vous donne une cellulite au niveau du plancher buccal au-dessus du muscle myloïdien. C'est le muscle du plancher de la bouche.

On prend l'insertion au niveau de la face interne, de la mandibule et il va vers l'os aïouïde. Si vous avez une cellulite qui va sous le muscle myloïdien, c'est une cellulite cervico-faciale et ça descend vers le bas. Si ça se déverse au-dessus du muscle myloïdien, c'est un hamac.

Il va pousser la langue, c'est l'œdème de la base de la langue et il va donner une glossoptose. En postérieur, c'est l'asphyxie. L'angine de Ludwig est mortelle.

Je vais vous montrer une image. Vous voyez les formes topographiques que l'on peut trouver de toutes les couleurs. Ça, c'est un abcès.

L'abcès dentaire. C'est un abcès supériorité gingival. Vous voyez la carie.

C'est tout mignon, ça ne va pas tuer. Là, vous voyez l'abcès. Avec la lumière, c'est pas... L'abcès palatin, supériorité.

Ici, vous avez une cellulite jugale basse. C'est pas visible, mais il y a des signes. Ici, il y a un placard inflammatoire.

Vous voyez ? Rouge. C'est-à-dire que c'est déjà évolué. On a vu que quand on a des signes cutanés, c'est que c'est déjà évolué.

Vous voyez ici, c'est un état... La peau, il y a des croûtes, il est inflammatoire, en état de pré-vestibulisation vestibulaire supérieure. L'angine de Ludwig, vous voyez ? C'est très... Quand vous allez prendre les slides, ça va être plus explicite. Vous voyez, tout est... Tout est inflammé, tout est enflé.

Alors, diagnostic différentiel. Quand vous avez une cellulite faciale, c'est-à-dire une cellulite d'origine dentaire, à part si vous le casez dans le... Dans la cellulite d'origine dentaire. Mais il faut toujours avoir à l'esprit qu'il peut y avoir d'autres choses encore plus graves.

Vous pouvez avoir des dysplasies osseuses. C'est un os qui est d'emblée malade, constitutionnellement malade, qui se défend mal et qui va se solder par une ostéite. L'ostéite va donner une cellulite.

C'est pour ça que quand on demande un orthopantomogramme pour voir l'état de la trame osseuse, comment elle est, pour dire est-ce que c'est juste une cellulite d'origine dentaire, déjà il y a un problème ou là il y a un problème structurel sous-jacent qui est encore plus grave. Il peut y

avoir un cancer. Que ce soit un cancer mucueux, ou là une tumeur osseuse qui se surinfecte.

Toute la case des tumeurs surinfectées. D'accord ? Il faut traiter la cellulite puis après traiter la tumeur. Vous avez les fractures négligées.

Normalement, les fractures de la portion dentée des maxillaires sont considérées comme des fractures ouvertes. Une fracture de la portion dentée de la mandibule c'est une fracture ouverte. Ce qui s'accompagne souvent, on dit qu'une plaie de l'agent C, on parle carrément de fracture de l'agent C. Fracture de l'os, mais on a aussi une fracture de l'agent C. Elle ouvre du milieu intérieur sur le milieu extérieur qui est sceptique.

Bien sûr, s'il n'y a pas de protection avec des antibiotiques, s'il n'y a pas d'hygiène, le patient ne peut pas se brosser avec des bains de gauche. S'il ne se fait pas opérer ou la traiter à temps, il s'exprimera par une cellulite. Cette cellulite est greffée sur une fracture faciale.

On a des causes infectieuses spécifiques. On n'a pas dit tuberculose, mais parmi les causes spécifiques de cellulite ou de la ostéocellulite maxillaire, c'est une infection par une bactérie qu'on appelle *Lactinomyces israeli*. Lactinomycoses maxillaire.

Elle est traitée par de l'amoxicilline. Amoxicilline au long cours. Et pour quelques cas rares, les curtages chirurgicaux.

ORN, Osteoradionécrose. Des patients qui ont eu déjà les antécédents d'une radiothérapie pour une tumeur quelconque, qu'elle soit maxillofaciale, ORL, verront développer pour des degrés différents une ostéoradionécrose. L'os se défend mal.

La prévention de cette ostéoradionécrose, c'est le traitement des dents cariées préalablement à la radiothérapie et le port de gouttières fluorées. On met du fluor dans des gouttières très longtemps. Le patient va les porter très longtemps pour lutter contre l'ostéoradionécrose.

Et puis vous avez des cellulites d'origine sinusienne. Comme la cavité buccale est porteuse de flore bactérienne, ça profite. Au niveau des sinus, ce sont des cavités qui sont septiques.

Donc une sinusite peut s'exprimer à l'extérieur et donner une cellulite faciale. On peut discuter des diagnoses différentielles d'une autre manière. Selon les localisations, il faut penser à des tuméfactions fébriles dues à des organes autres que les maxillaires.

Une basie jugale, il faut penser à une somaxilite litiasique. La glande somaxilaire peut être sujette à un calcul qui peut se surinfecter. Une salive qui stagne et qui dit somaxilite, dit adénite.

Parce que c'est un relais ganglionnaire. Écrivez-le. Il y a des oublis.

Mettez adénite. Derrière, on peut avoir une parotidite. Qu'elle soit virale, bactérienne ou litiasique.

On a des causes qui sont médicales. C'est des cellulites faciales d'origine. Le germe en cause.

C'est une tuméfaction, c'est un placard. Le contexte est autre. Si vous mettez le doigt dans le vestibule, il est libre.

Vous posez quand même des questions. Vous faites un scanner, les sinus sont libres. Vous lui posez la question, il avait une pharyngite.

Vous faites un dosage des des aslos et vous voyez des aslos qui sont donc euh, qui montent en pique et vous avez le diagnostic. Rappelez-vous de l'hérésie pelle. C'est un piège.

Donc je parie c'est un hérésie pelle, il fait les aslos, le parédiéli parce que je pense à l'hérésie pelle, lui il veut me coller à tout prix euh, une cellulite pour l'opérer, je sais que c'est pas une cellulite. Vous pensez à ça, aux causes médicales, vous pensez aussi aux causes dermatologiques, vous avez des papules, vous avez des pustules, voilà donc euh, très important. Donc la cellulite d'origine dentaire mais il ne faut pas perdre de vue la dysplasie, le cancer, la fracture, les causes spécifiques, les osteoradionécroses et les causes sinusiennes et puis toutes les causes de masse on a de tuméfaction fébrile.

Donc on a parlé de d'orthopantomogramme pour tout ce qui est cellulite circonscrite inflammatoire, d'accord? En dehors de ça, le gold standard c'est la TDM cervicofacial avec injection de produits de contraste. Elle lâche parce qu'il va nous, va nous localiser les zones de nécrose, les zones de collection parce que quand on va injecter le produit de contraste, il va fuser là où c'est vascularisé, mais là où c'est nécrotique, il n'y a pas de prise de contraste, d'accord? Comme ça pour orienter la voie d'abord, si on passe par la peau, si on passe par le vestibule, si on passe par l'intérieur, la face interne des maxillaires, le dentascanère ou Conebim, on peut aussi parler de Conebim pour toutes les fois où on a des, des formes subaiguës ou quelques formes de cellulite circonscrite comme les abcès, supériorité. D'accord, d'où viennent les facilles nécrosantes? Une cellulite peut donner ça.

C'est de la peau et des facilles qui sont nécrosées et là ça fait appel à des gestes de reconstruction très importants, on va faire tourner des lombos et tout ça, donc vous imaginez la suite, hein? Donc déjà la lourdeur des gestes opératoires et les complications et les ronçons. Tout ce qui est maxillaire, c'est la thrombophlébite, vous avez des complications orbitaires, proche en proche, imaginez vous avez une dent et vous perdez l'œil. C'est quand même assez fâcheux, puis vous avez la thrombophlébite du sinus caverneux.

Principe de traitement, devant toutes cellulites d'origine dentaire, toutes cellulites des jambes faciales, la forcée d'origine dentaire, à l'arrière de la dent, non, pour hospitaliser. Donc le traitement ne se conçoit que dans un cadre hospitalier. Donc toutes les fois où j'entends mes collègues dentistes traiter des cellulites au fauteuil, ça mérisse les cheveux.

Donc on commence par une antibiotérapie à large spectre, on a vu que c'était une flore pour les polymicrobiennes, en intraveineuse directe, qu'on adaptera en fonction du prélèvement qu'on fera

au père opératoire, s'il y a collection, et on indique les corticoïdes, mais c'est des anti-inflammatoires, les corticoïdes, que s'il y a des gènes ou là des placards inflammatoires cutanés. Comment je fais ? Quand j'ai un patient qui arrive avec un placard, je trace avec un feutre permanent les contours de mon placard, et je le mets sous antibiotiques et sous corticoïdes. Je reviens dans 2-3 heures, je vois si le placard a régressé, je fais un autre contour.

Ainsi de suite, ça me permet déjà de monitorer l'étendue du placard. Quels sont les gènes ? Je dirais que les gènes à l'ouverture buccale c'est une indication aux corticoïdes, c'est-à-dire que la gène à l'ouverture buccale peut être même un signe d'une cellulite circonscrite. Postérieur, la gène à l'ouverture buccale n'est pas une indication aux corticoïdes.

Il y a d'autres gènes. Les gènes respiratoires. Dyspnée.

Quoi d'autre ? Une gène à l'élocution. Vous lui posez la question. Il a du mal à articuler des mots.

Gène à l'élocution, gène à la respiration, gène à la déglutition. Il a du mal. Toute cette sphère est blindée.

Vous voyez très bien que tout ce qui se rapporte est aérodigestif. L'élocution fait une partie de la respiration. C'est une respiration qui est orientée.

C'est de l'air qui sort. Il ne peut ni inhaler, ni expirer, ni coordonner. Il y a une coordination au niveau de l'élocution.

Gène à l'élocution, à la déglutition et à la respiration. Gène à l'ouverture buccale n'est pas une indication aux corticoïdes. Au moindre doute, c'est très difficile de gérer des corticoïdes quand on a des diabétiques.

Les corticoïdes déséquilibrent la glycémie. Pour les fundamentalistes, on dit que la dent, normalement, il faut la traiter. Donc, il faut la traiter, faire un traitement canalaire, une résection périapicale.

De ma part, pour mon humble expérience, une dent qui fait parler d'elle, je la vire. J'ai eu des patients chez qui j'étais conservateur et qui sont venus avec des tableaux similaires une deuxième fois, une troisième fois. Maintenant, je ne suis plus totalitaire.

Mais le principe, on traite la cellulite, on traite la dent causale et on traite les dents qui sont à côté parce qu'on ne fasse pas de tableaux similaires. Le drainage, le plus souvent, sous anesthésie générale et on traite les dents adjacentes pour la prévention. Et en cas de sepsis grave, c'est des mesures de réanimation.

Pour les patients qui nécessitent une tracheotomie, chez qui on a besoin d'intuber, on intube. Et chez qui on a besoin d'assistance circulatoire pour les drogues, les vasopresseurs, donc l'adrénaline et compagnie, on les passe à la réanimation. Donc, vous voyez que tout cela ne peut

se concevoir qu'en milieu hospitalier.

D'accord ? Je passe des messages. Pour les gens qui disent que c'est un oblacé du vide, c'est bon, antibiotiques, rentrez chez vous. D'accord ? J'ai vu des drames.

J'ai vu des décès qui s'embêtent. J'ai vu aussi des gens qui ont été repêchés. Antibiothérapie large-spectre, corticoïdes cislène et placard, traitement de la dent causale, drainage ciscollection, traitement des dents adjacentes dans la prévention et mesure des réanimations quand c'est nécessaire.

Alors, on a dit qu'il y avait des cellules qui sont bénignes, diagnostic précoce et traitement adapté, instauré. C'est la sédation des symptômes en 48 heures, le drainage est évité et la dent, entre guillemets, je mets ça ici, entre guillemets, mais l'essentiel, c'est que les choses rentrent dans l'ordre en 48 heures et on évite toute la batterie de médication lourde en aval. Les cellules malignes sont mortelles, rappelez-vous.

Thérapie lourde, réanimation, vous vous rappelez de cette facilité écrasante, on peut tomber facilement dans ces cas de figure. Je vous ai mis avec la photo comme ça pour que le reste reste gravé dans votre mémoire. Un coup, comme ça, écorché, un visage qui semble apparent, un thorax qui est écorché, et puis quand on opère, c'est des gestes de débridement, on ouvre l'arche, c'est une chirurgie qui n'est pas faite avec des instruments, c'est avec le doigt que ça se fait.

On ouvre, fin pertuit, et avec le doigt on va chercher les logètes. D'accord ? Quand on a un élément qui résiste, on ne tire pas. C'est le message que je vais passer à mes résidents.

S'ils tirent sur quelque chose, c'est probablement une artère ou un nerf, un nerf lingual, une grande hypoglosse, une artère faciale. C'est une chirurgie qui se fait par la voie d'abord, elle se fait au doigt. Et c'est un lavage.

Bon. Exceptionnellement, quelques gestes de d'assainissement de nécrose. Quand il y a des zones de nécrose, on va les chercher.

Sinon, eux, ils vont maintenir l'infection, mais on utilise peu d'instruments. Donc, des fois, en tirant sur des éléments nerveux, on va avoir une dysphonie, une dysphagie, parce qu'on va aller très loin autour des viscères et autour du cractus digestif. Le patient a besoin de rééducation par la suite, des troubles de trophicité, des cicatrices qui sont mal... disgracieuses.

Donc, pour éviter tout cela, c'est le diagnostic précoce. Et si on ne peut pas tomber carrément dans le cadre de cellulite, c'est encore mieux. En allant chez le dentiste au moins une fois par an.

D'accord? INS Je ne fais pas de publicité pour les dentistes, mais c'est important. Alors, la prochaine fois, on traitera les tumeurs bénignes et malignes des maxillaires. Merci.